

INFORME DE LÓGICA ACTUAL

Criterios AGS Beers 2023 en SIGRAM

Relación entre el paper, la tabla operativa B01-B23 y el motor de evaluación clínica.

Mensaje central. Un medicamento encontrado no equivale a una alerta. El medicamento identifica criterios candidatos; SIGRAM evalúa después las condiciones exactas del paciente.

1. Cómo se complementan las tres capas

La tabla B01-B23 no reemplaza el paper AGS Beers. Es la capa operativa que permite aplicar el conocimiento clínico al universo de medicamentos priorizados del piloto.

Capa	Función
AGS Beers 2023	Mantiene el criterio clínico original, la recomendación, el fundamento y la evidencia.
Tabla B01-B23	Relaciona medicamentos y grupos farmacológicos de ESSI con los criterios Beers que pueden ser relevantes.
SIGRAM	Evalúa los datos del paciente y muestra un resultado trazable, sin sustituir el juicio clínico.

2. Recorrido operativo en SIGRAM

MEDICAMENTO IDENTIFICADO EN ESSI
↓
GRUPO FARMACOLÓGICO
↓
CRITERIOS BEERS CANDIDATOS (B01-B23)
↓
DATOS CLÍNICOS, LABORATORIOS Y ANTECEDENTES
↓
ACTIVADO / REQUIERE INFORMACIÓN / REVISIÓN CLÍNICA / SIN HALLAZGO / NO APLICABLE

Ejemplo: diclofenaco puede ser candidato a varios criterios, pero cada uno plantea una pregunta distinta.

DICLOFENACO
B05: duración, riesgo gastrointestinal y gastroprotección
B06: insuficiencia cardiaca y estado sintomático
B07: antecedente de úlcera y gastroprotección
B08: depuración de creatinina (CrCl)

Conclusión: diclofenaco asociado a B05-B08 no significa cuatro alertas. Significa cuatro evaluaciones clínicas posibles.

3. Casos especiales: por qué el medicamento no basta

Caso	Qué debe verificarse	Respuesta actual de SIGRAM
B04 - IBP	Duración del tratamiento e indicación de mantenimiento.	Más de 8 semanas sin justificación: activado. Datos ausentes: requiere información.
B06 - AINE e IC	Presencia de insuficiencia cardiaca y si es sintomática.	Sin IC: no aplicable. IC sin estado: requiere información. Asintomática: precaución. Sintomática: evitar.
B16 - opioide + gabapentina	Combinación simultánea y si existe transición/reducción de opioides.	Detecta el riesgo, pero conserva la excepción clínica documentada.
B17 - fármacos SNC	Tres o más fármacos de clases específicas activas en SNC.	Con 2: sin hallazgo. Con 3 o más: activado y se muestran los medicamentos contados.
B19/B20 - función renal	CrCl documentada; y, para tramadol, formulación.	Sin CrCl: requiere información. Gabapentina + CrCl <60: reducir dosis. Tramadol + CrCl <30: inmediata reducir; prolongada evitar.
B21 - SRA en ERC	ERC estadio 3a+ y combinación farmacológica específica.	Se activa con doble SRA o SRA + amilorida/triamtereno, solo si ERC 3a+ está confirmada.
B23 - tamsulosina	Síncope/hipotensión ortostática y valoración individual.	Revisión clínica manual; no se presenta como "evitar" automático.

4. B03 y la Tabla 7: clasificación, no alerta

B03 es el caso más importante para comprender la nueva lógica. La Tabla 7 de AGS Beers identifica medicamentos con propiedades anticolinérgicas fuertes. Es una lista de referencia para otros criterios; no equivale, por sí sola, a una recomendación de “evitar”.

Antes	Ahora
Orfenadrina detectada → B03 → alerta.	Orfenadrina detectada → B03: “anticolinérgico fuerte” → clasificación de apoyo.



B03 no dice: “el paciente tiene un problema”. **Dice:** “este medicamento puede contribuir a un problema si existe una condición clínica o una combinación de riesgo”.

5. Cuándo sí aparece una alerta relacionada con B03

Situación	Resultado
Orfenadrina sola	B03 se conserva como clasificación de apoyo. No aparece una alerta por B03.
Orfenadrina + otro anticolinérgico fuerte	B18 puede activarse por carga anticolinérgica: dos o más fármacos anticolinérgicos fuertes.
Anticolinérgico fuerte + delirium	Se vuelve relevante el criterio de Tabla 3 sobre delirium; requiere evaluar el contexto clínico.
Anticolinérgico fuerte + demencia/deterioro cognitivo	Se vuelve relevante el criterio de Tabla 3 correspondiente; requiere contexto clínico.
Anticolinérgico fuerte + caídas/fracturas	Se evalúa el criterio de Tabla 3 sobre caídas o fracturas.

ORFENADRINA

↓
B03: ¿ANTICOLINÉRGICO FUERTE? → SÍ
↓
¿HAY OTRO ANTICOLINÉRGICO FUERTE?
└ NO → B03 queda como clasificación de apoyo
└ SÍ → B18 puede activarse

6. Ejemplos de lectura clínica

Paciente	Lectura correcta
Paciente A: orfenadrina solamente	B03 identifica la propiedad anticolinérgica. No se genera un hallazgo Beers independiente solo por esta clasificación.
Paciente B: orfenadrina + otro anticolinérgico fuerte	B03 identifica ambos fármacos y B18 se puede activar por combinación/carga anticolinérgica.
Paciente C: orfenadrina + demencia documentada	B03 aporta la clasificación; SIGRAM evalúa el criterio clínico de Tabla 3 que corresponda al deterioro cognitivo.
Paciente D: diclofenaco + IC sintomática	B06 se activa y la recomendación se presenta como “Evitar”.

7. Resultado esperado

- Menos falsos positivos: el medicamento aislado no se confunde con una alerta clínica.
- Mayor transparencia: cada resultado puede explicar medicamento, criterio, condición usada y fuente AGS.
- Mejor integración futura con ESSI: al llegar diagnósticos, triaje y laboratorios, los criterios pasan de requerir información a poder evaluarse.
- Seguridad metodológica: las zonas de incertidumbre se muestran como revisión clínica o información faltante, no como conclusiones automáticas.

Nota de alcance

SIGRAM-AM es un sistema de tamizaje y apoyo a la revisión clínica. La evaluación automatizada no reemplaza el juicio profesional ni constituye una indicación terapéutica.